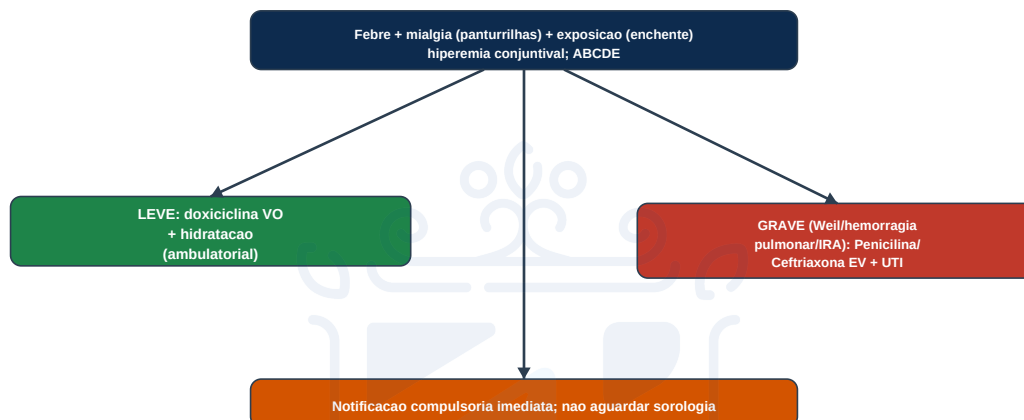


LEPTOSPIROSE — WEIL + ATB PRECOCE

FLUXOGRAMA — TRATAR NA SUSPEITA

LEPTOSPIROSE — SUSPEITA -> ATB IMEDIATO



DEFINIÇÃO E EPIDEMIOLOGIA

O QUE É

- Doença bacteriana aguda sistêmica por espiroquetas (*Leptospira interrogans*); de leve autolimitada a multissistêmica fatal
- Forma grave = SÍNDROME DE WEIL: icterícia + insuficiência renal aguda + hemorragias (especialmente PULMONAR) + choque
- Transmissão: contato de pele lesada/mucosas com água, lama ou solo contaminados por urina de animais (ratos = principal reservatório)
- Fatores: enchentes/alagamentos, exposição ocupacional (lixo, esgoto, agricultura), falta de saneamento, contato recreacional
- Notificação COMPULSÓRIA imediata

AValiação (ABCDE) E ANAMNESE

O QUE BUSCAR

- A/B: nível de consciência, taquipneia/hipoxemia, HEMOPTISE (hemorragia alveolar); C: PA/FC/TEC, choque; D: confusão/rebaixamento; E: icterícia, petéquias, sangramentos, mialgia intensa de panturrilhas
- Anamnese: febre súbita, cefaleia intensa, mialgia importante (panturrilhas/lombar), náuseas/vômitos/diarreia, icterícia, redução da diurese, sangramentos
- Exposição recente: enchente/alagamento, contato com lama/água contaminada, presença de roedores
- Exame: febre, dor muscular à palpação, HIPEREMIA CONJUNTIVAL bilateral (achado típico), icterícia, hipotensão, estertores, oligúria
- Diferenciais: dengue, hepatites, febre maculosa, malária, sepse de outra origem

CLASSIFICAÇÃO DE GRAVIDADE

Forma	Características
Leve	Febre, cefaleia, mialgia, sem disfunção orgânica
Moderada	Náuseas/vômitos persistentes, alteração discreta renal/hepática, hipotensão responsiva a fluidos
Grave (Weil)	Icterícia + IRA; hemorragia PULMONAR; choque refratário; alteração neurológica; plaquetopenia; acidose; necessidade de VM/diálise

ANTIBIOTICOTERAPIA — INICIAR NA SUSPEITA

Rx NÃO AGUARDAR CONFIRMAÇÃO

Iniciar IMEDIATAMENTE na suspeita clínica, sem aguardar sorologia

LEVE (ambulatorial): Doxiciclina 100 mg VO 12/12h por 7 dias

Contraindicações à doxiciclina (gestante, lactente, < 8 anos): Amoxicilina 500 mg VO 8/8h por 7 dias ou Azitromicina 500 mg/dia por 5 dias

MODERADA/GRAVE (internação): Penicilina G cristalina 1,5 milhão UI EV 6/6h por 7 dias

Alternativas equivalentes: Ceftriaxona 1-2 g EV/dia ou Cefotaxima 1 g EV 6/6h (eficácia semelhante)

Coletar exames antes do ATB se possível (sem atrasar); sorologia IgM (ELISA) — não aguardar resultado

SUPOORTE (ESSENCIAL NAS FORMAS GRAVES)

Rx ÓRGÃO A ÓRGÃO

Hidratação: cristalóide (SF 0,9%); bolus cauteloso no choque; EVITAR sobrecarga na IRA

Analgesia/antitérmico: Dipirona ou Paracetamol — EVITAR AINES (agravam IRA e sangramentos)

IRA: monitorar creatinina/diurese; DIÁLISE PRECOCE se anúria persistente, acidose grave, hipercalemia ou sobrecarga

Hemorragia pulmonar: O2 de alto fluxo, VM precoce se necessário, UTI imediata

Choque: reposição volêmica + noradrenalina (protocolo de sepse)

Exames: hemograma (plaquetopenia), função renal/hepática, eletrólitos, CPK, gasometria, RX de tórax

INTERNAÇÃO x ALTA

DECISÃO

- ☐ INTERNAR: qualquer forma moderada/grave, icterícia, IRA, sangramentos, hipotensão, alteração neurológica, incapacidade de VO
- ☐ ALTA (forma leve): estável, função renal preservada, boa aceitação oral, ATB iniciado, retorno garantido
- ☐ Casa (leve): Doxiciclina 100 mg 12/12h (ou Amoxicilina 500 mg 8/8h) por 7 dias + Dipirona + hidratação + repouso
- ☐ Transferência: leptospirose grave, instabilidade, IRA com necessidade de diálise, hemorragia pulmonar, necessidade de UTI
- ☐ Notificação compulsória imediata à Vigilância Epidemiológica

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos; suspeita de leptospirose (forma ____); exposição: ____ (enchente/lama/roedores) há ____ dias.
- Gravidade: ____ (icterícia/IRA/hemorragia pulmonar/choque/neurológico); sinais vitais ____, diurese ____, SpO2 ____.
- Exames: creatinina ____, plaquetas ____, bilirrubinas ____; ATB iniciado ____ às ____; volume/vasopressor ____.
- Solicito hospital com UTI/Nefrologia (diálise) para suporte avançado; notificar Vigilância.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

A síndrome de Weil (leptospirose grave) caracteriza-se por:

- A) Artralgia crônica e exantema
- B) Icterícia + insuficiência renal aguda + hemorragias (especialmente pulmonar)
- C) Microcefalia fetal
- D) Tosse com guincho
- E) Úlcera genital

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o antibiótico de escolha para a leptospirose LEVE (ambulatorial) em adulto não gestante?

- A) Penicilina G cristalina EV
- B) Doxiciclina 100 mg VO 12/12h por 7 dias
- C) Vancomicina
- D) Metronidazol
- E) Fluconazol

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Quando iniciar o tratamento da leptospirose?

- A) Somente após sorologia IgM positiva
- B) Imediatamente na suspeita clínica, sem aguardar confirmação
- C) Após 48h de observação
- D) Apenas se houver icterícia
- E) Após hemocultura positiva

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual achado de exame físico é típico da leptospirose?

- A) Exantema pruriginoso
- B) Hiperemia conjuntival bilateral e mialgia intensa de panturrilhas
- C) Sopro cardíaco
- D) Rigidez de nuca isolada
- E) Esplenomegalia maciça

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual classe de analgésico deve ser EVITADA na leptospirose?

- A) Paracetamol
- B) AINEs (agravam insuficiência renal e sangramentos)
- C) Dipirona
- D) Opioides fracos
- E) Nenhuma

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A síndrome de Weil é a forma grave: icterícia + insuficiência renal aguda + hemorragias (especialmente pulmonar), podendo evoluir com choque e falência múltipla.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Na forma leve, a doxiciclina 100 mg VO 12/12h por 7 dias é a escolha; em gestantes/lactentes/< 8 anos usa-se amoxicilina ou azitromicina.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O tratamento deve ser iniciado imediatamente na suspeita clínica, sem aguardar a sorologia, pois o início precoce do antibiótico melhora o prognóstico.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Hiperemia conjuntival bilateral e mialgia intensa das panturrilhas são achados típicos da leptospirose, em contexto epidemiológico compatível.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Os AINEs devem ser evitados por agravarem a insuficiência renal e o risco de sangramento; usa-se dipirona/paracetamol para febre e dor.

SM24
Suporte ao Plantão Médico